

Comenzado el	viernes, 6 de diciembre de 2024, 10:08
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 6 de diciembre de 2024, 10:53
Tiempo empleado	44 minutos 26 segundos
Puntos	0,00/90,00
Calificación	0,00 de 100,00

Pregunta 1

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 35 años, multípara de 1, se realiza PAP de control, que es informado como presencia de atipias escamosas de significado incierto (ASC-US). Su especuloscopia es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Realizar colposcopia y biopsia cervical
- ☐ b. Solicitar reacción de cadena de polimerasa para virus papiloma humano
- ☐ c. Realizar diatermocoagulación cervical
- ☐ d. Realizar histerectomía
- ☐ e. Realizar biopsia de endometrio

Manejo de ASCUS (Células Escamosas Atípicas de Significado Incierto): Vale la pena recordar que las indicaciones más importantes para realizar una colposcopia y biopsia cervical son:

Lesión cervical independiente del resultado de la prueba de Papanicolaou (PAP).

PAP de tipo glandular, independientemente del grado.

PAP escamoso de alto grado.

Presencia del virus del papiloma humano (VPH) de alto grado, independientemente del resultado del PAP.

PAP escamoso de bajo grado con VPH de bajo grado.

Con lo anterior, se puede deducir el manejo de las ASCUS: existes 3 opciones: observar, controlar en 1 año y solicitar una prueba de VPH (la más aceptada). Si VPH(+): Se realiza colposcopia y biopsia, ya que cumple con el criterio de PAP de bajo grado más VPH de bajo grado. Si VPH(-): Se puede optar por la observación o un nuevo PAP en 6 a 12 meses. La opción más recomendada por las guías internacionales es solicitar un nuevo PAP.

En menores de 25 años con ASCUS, también se solicita la prueba de VPH, pero se sigue en 1 (si VPH+) o 3 años (si VPH-).

La respuesta correcta es: Solicitar reacción de cadena de polimerasa para virus papiloma humano

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 72 años, fumador de 40 paquetes/año, con diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas sin tratamiento actual, presenta un cuadro de 7 días de evolución de cefalea y tendencia a la desorientación. En sus exámenes destaca una concentración sérica de sodio de 121 mEq/L, sin focalidad neurológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. SIADH (Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética)
- ☐ b. Metástasis cerebrales
- ☐ c. Síndrome carcinoide
- ☐ d. Accidente vascular encefálico
- ☐ e. Hipercalcemia

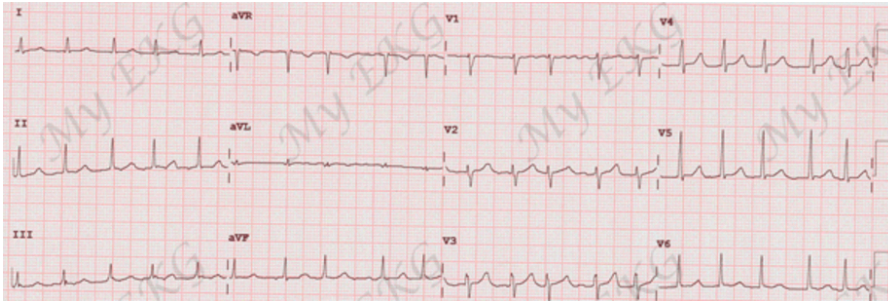
Síndrome de Secreción Inapropiada de Hormona Antidiurética (SIADH): El caso describe un SIADH clásico con hiponatremia severa y compromiso neurológico. La causa en este caso es el cáncer de pulmón, ya que las alteraciones del sistema nervioso central y las alteraciones pulmonares son las causas más frecuentes de SIADH. Por el compromiso neurológico, se debe tratar con suero hipertónico a pasar muy lento, para evitar la mielinolisis pontina. Si hubiese estado bien, se maneja solo con restricción de agua libre.

La respuesta correcta es: SIADH (Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética)

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente hipertenso en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, y con antecedentes de asma en tratamiento con inhaladores, consulta por palpitaciones, asociadas a disnea y angustia. Al examen físico se constata taquicardia con frecuencia cardíaca de 124 latidos por minuto y presión arterial de 80/40 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación (fuente: myekg.com):



¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Desfibrilación
- ☐ b. Amiodarona endovenosa
- ☐ c. Propranolol endovenoso
- ☐ d. Adenosina endovenosa
- ☐ e. Cardioversión eléctrica

Manejo de la Fibrilación Auricular Hemodinámicamente Inestable: En el caso de una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que cause inestabilidad hemodinámica, se debe realizar cardioversión eléctrica inmediata (no confundirla con la desfibrilación eléctrica, que se usa en el paro). Este manejo se aplica a cualquier tipo de taquiarritmia con hemodinamia inestable. Si la fibrilación auricular hubiera presentado una hemodinamia estable, el manejo inicial habría sido disminuir la frecuencia cardíaca con propranolol endovenoso.

La respuesta correcta es: Cardioversión eléctrica

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un niño de 5 años, nacido a las 32 semanas por parto vaginal, es llevado a control porque se acerca mucho a la pantalla cuando ve televisión. La inspección ocular es normal. La agudeza visual es de 20/25 en el ojo derecho y 20/80 en el ojo izquierdo, la cual mejora a 20/25 al usar un agujero estenoico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Ambliopía
- ☐ b. Microftalmia
- ☐ c. Ametropía
- ☐ d. Glaucoma congénito
- ☐ e. Retinopatía del prematuro

Vicios de Refracción y Agudeza Visual: La mejora de la agudeza visual al mirar a través de un agujero estenoico es característica de los vicios de refracción, también conocidos como ametropías. En este caso, no hay ambliopía porque la agudeza visual se corrige completamente. Si la agudeza visual solo hubiera mejorado parcialmente con la corrección de la ametropía, el diagnóstico también habría incluido ambliopía anisométrica.

La respuesta correcta es: Ametropía

Pregunta 5

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial y una válvula cardíaca aórtica mecánica, anticoagulado con antagonistas de la vitamina K, ingresa al servicio de urgencias por un episodio de hemorragia digestiva alta, con signos de inestabilidad hemodinámica. Además de la administración de fluidos y la solicitud de una endoscopia digestiva alta con urgencia, ¿cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

- ☐ a. Administrar vitamina K por vía endovenosa
- ☐ b. Transfundir sangre completa
- ☐ c. Administrar ácido tranexámico endovenoso
- ☐ d. Administrar plasma fresco congelado endovenoso
- ☐ e. Administrar factor VII recombinante endovenoso

Antídoto para los Cumarínicos: El antídoto para los cumarínicos o antagonistas de la vitamina K varía según la urgencia para revertir su efecto. Reversión inmediata: Se debe administrar plasma fresco congelado. Reversión no urgente: Se debe administrar vitamina K.

La respuesta correcta es: Administrar plasma fresco congelado endovenoso

Sin contestar

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes medidas se considera más adecuada para prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores entre 60 y 75 años?

- ☐ a. Higiene del sueño
- ☐ b. Terapia de relajación
- ☐ c. Ejercicio físico y estudio activo
- ☐ d. Actividades manuales frecuentes
- ☐ e. Administración oral de vitamina C y folatos

Mantenimiento de la Salud en Adultos Mayores: El ejercicio físico y el estudio activo son las medidas que han demostrado mayor impacto en mantener la salud física, cognitiva y mental de los adultos mayores..

La respuesta correcta es: Ejercicio físico y estudio activo

Pregunta 7

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 30 años, consulta debido a que se siente deprimido. Es padre de tres hijos con tres mujeres diferentes, tiene antecedentes de múltiples fracasos académicos y laborales y se encuentra sin actividad laboral en la actualidad. Al interrogatorio, consume alcohol con cierta frecuencia, bebiendo 3 o 4 días a la semana en cantidad que él considera moderada, aunque reconoce que se emborracha los fines de semana. Además, con frecuencia se involucra en actividades riesgosas y presenta una autoimagen negativa. En el pasado, ha tenido ideación suicida con autoagresión, aunque no la tiene en la actualidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Esquizofrenia
- ☐ b. Trastorno de conducta
- ☐ c. Trastorno de personalidad límite
- ☐ d. Trastorno bipolar
- ☐ e. Trastorno adaptativo

Trastorno de Personalidad Límite: El caso presentado describe un trastorno de personalidad límite clásico. Se recomienda revisar el resumen de psiquiatría.

La respuesta correcta es: Trastorno de personalidad límite

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Usted atiende a un recién nacido de 10 días de vida, junto a su madre. Nació por parto vaginal sin complicaciones, pesando 3.200 gramos al nacer y 3.050 gramos al momento del alta. La madre refiere que presenta llanto frecuente y permanece constantemente prendido al pecho, por lo que sospecha que tiene dolor abdominal. Al examen físico, el niño llora vigorosamente y se observa en buen estado general. Su peso actual es de 3.350 gramos. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?

- ☐ a. Agregar fórmula láctea después de cada toma
- ☐ b. Indicar a la madre que suspenda el consumo de lácteos y reevaluar al niño
- ☐ c. Citar a control en 24 horas
- ☐ d. Reforzar la técnica de lactancia materna
- ☐ e. Prescribir lactobacillus reuteri

Peso en Recién Nacidos: Es normal que un recién nacido pierda hasta un 10% de su peso durante los primeros días de vida, el cual se recupera al cumplir los 7 días. Luego de la baja inicial, el incremento normal es de 20 a 25 g al día o más. En este caso, el recién nacido ha subido de peso adecuadamente, lo que sugiere que es un recién nacido normal. Por estar prendido al pecho todo el día, se asume que la técnica de lactancia no es óptima. Si no hubiese subido de peso, sería correcto mejorar la técnica de lactancia y, además, citar a control en 24 horas. El Lactobacillus reuteri se indica en los cólicos, pero son poco probables a esta edad..

La respuesta correcta es: Reforzar la técnica de lactancia materna

Pregunta 9

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un niño de 7 años se encuentra en el preoperatorio para una cirugía de fimosis. Se solicitan múltiples exámenes prequirúrgicos, entre los que se observa un examen de orina que reporta: 2-5 leucocitos por campo, 10-15 eritrocitos por campo y proteínas de 5 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Solicitar la determinación del índice albúmina/creatinina en orina
- ☐ b. Solicitar la determinación de creatinina y calcio en una muestra de orina aislada
- ☐ c. Repetir el examen de orina
- ☐ d. Solicitar proteinuria en orina de 24 horas
- ☐ e. Solicitar títulos de antistreptolisina O

Microhematuria Aislada en Niños: Un sedimento de orina muestra microhematuria. Los leucocitos y las proteínas están dentro del rango normal. El manejo de la microhematuria aislada en un niño generalmente consiste en repetir los análisis de orina.

Si la microhematuria persiste, se realiza un estudio completo para descartar glomerulonefritis y, luego, hematuria de origen urológico. Si al inicio hubiera leucocituria junto con la hematuria, se estudiaría como una infección urinaria. Si al inicio hubiera proteinuria junto con la hematuria, se estudiaría como una glomerulonefritis.

La respuesta correcta es: Repetir el examen de orina

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 32 años presenta vértigo intenso de 2 días de evolución, el que dificulta la marcha y se asocia a vómitos en múltiples oportunidades. Al examen físico se encuentra audición conservada y se objetiva un nistagmo unidireccional horizontal a derecha y lateropulsiones a izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Vértigo postural paroxístico benigno
- ☐ b. Migraña vertebrobasilar
- ☐ c. Parálisis vestibular periférica
- ☐ d. Accidente vascular encefálico de fosa posterior
- ☐ e. Enfermedad de Ménière

Vértigo Periférico: El caso describe un vértigo con características de vértigo periférico sin signos de alarma. La intensidad y duración de los síntomas sugieren una parálisis vestibular periférica o neuronitis vestibular. La enfermedad de Meniere presentaría síntomas auditivos. El vértigo postural paroxístico benigno suele durar solo unos segundos y se desencadena con los movimientos de la cabeza.

La respuesta correcta es: Parálisis vestibular periférica

Pregunta 11

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una mujer de 28 años consulta por un cuadro clínico de 3 meses de evolución caracterizado por artralgias y mialgias, astenia y eritema malar. Hace un mes, se agregó edema en miembros inferiores. Además, refiere la aparición de úlceras orales y orinas espumosas desde hace una semana. Al examen físico, sus signos vitales son normal, se evidencia alopecia en el cuero cabelludo y el eritema descrito. El hemograma reporta: leucocitos 2.800/mm³, plaquetas 90.000/mm³, hematocrito 30% y hemoglobina 10 g/dL con un VCM de 90 fL. El examen de orina muestra hematuria con 25 eritrocitos dismórficos por campo, proteinuria de 500 mg/día y la creatinina sérica resulta 2,0 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Vasculitis de vaso pequeño ANCA positivo
- ☐ b. Dermatomiositis con compromiso renal
- ☐ c. Lupus eritematoso sistémico
- ☐ d. Esclerosis sistémica progresiva
- ☐ e. Enfermedad mixta del tejido conectivo

Diagnóstico de Lupus: La clínica y los exámenes realizados orientan fuertemente hacia un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico clásico.

La respuesta correcta es: Lupus eritematoso sistémico

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 56 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir un accidente automovilístico de alta energía. Presenta múltiples lesiones, hemorragia masiva, taquicardia, hipotensión e inestabilidad hemodinámica. Se sospecha una fractura de pelvis en el examen físico. Se solicitan imágenes, entre las que se informan una TAC cerebral con un hematoma subdural izquierdo con desplazamiento de 11 mm desde la línea media de la masa encefálica; una TAC de tórax revela múltiples fracturas costales, neumotórax izquierdo con desplazamiento de la tráquea hacia la derecha; TAC de abdomen y pelvis con fractura de pelvis desplazada. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas es la más urgente?

- ☐ a. Intubación orotraqueal
- ☐ b. Laparotomía exploradora
- ☐ c. Evacuación quirúrgica del hematoma subdural
- ☐ d. Pleurostomía izquierda
- ☐ e. Estabilización de la fractura de pelvis con un dispositivo de compresión neumática

Neumotórax a Tensión: El paciente presenta múltiples lesiones, pero la más urgente de atender es un neumotórax a tensión (desplazamiento de la tráquea e hipotensión arterial). En este contexto, la pleurostomía se presenta como el procedimiento más urgente.

La respuesta correcta es: Pleurostomía izquierda

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea diagnosticada hace 14 días, presenta desde hace 3 días ardor en los ojos, lesiones en la boca, malestar general y aparición de un rash cutáneo. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival bilateral, úlceras orales y un exantema con pápulas y placas eritematosas en tronco y extremidades. La inspección facial muestra lo siguiente (fuente: prontopele.com.br):



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Síndrome de Stevens-Johnson
- ☐ b. Gingivoestomatitis herpética
- ☐ c. Necrólisis epidérmica tóxica
- ☐ d. Pénfigo
- ☐ e. Escarlatina

Síndrome de Stevens-Johnson: El cuadro clínico presentado, junto con la imagen, son característicos del síndrome de Stevens-Johnson.

La respuesta correcta es: Síndrome de Stevens-Johnson

Pregunta 14

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 34 años, cursando un embarazo de 38 semanas, ingresa en trabajo de parto. Presenta dinámica uterina adecuada, espontánea, de 4 contracciones uterinas cada 10 minutos, membranas rotas y 9 cm de dilatación. Se aprecia la cabeza fetal en presentación cefálica, en variedad de posición nasopúbica, en espinas +2. El registro fetal basal es de 120 latidos por minuto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Realizar rotación manual de la cabeza fetal y parto vaginal
- ☐ b. Esperar el descenso completo de la cabeza fetal y realizar fórceps
- ☐ c. Realizar cesárea de urgencia
- ☐ d. Solicitar perfil biofísico fetal
- ☐ e. Dejar evolución espontánea del trabajo de parto

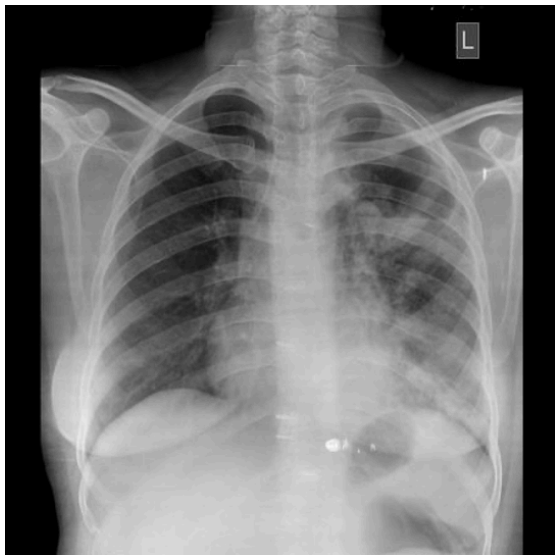
Presentación de Frente: La posición nasopúbica del feto indica que se encuentra en presentación de frente. Esta situación contraindica de forma absoluta el parto vaginal, por lo que se debe realizar una cesárea.

La respuesta correcta es: Realizar cesárea de urgencia

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una mujer de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de tos con expectoración mucopurulenta, asociada a sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre intermitente. Al examen físico tiene T°: 37,1°C, PA: 130/82 mmHg, FC: 96x', saturación O2: 96% y a la auscultación pulmonar se oyen estertores y crépitos bilaterales. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra más abajo (fuente: Radiopaedia). Se solicitan baciloscopías de expectoración, que resultan negativas y prueba de quantiferón-TB, que también resulta negativa. Su marido está en tratamiento antituberculoso por tuberculosis pulmonar activa.



¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de esta paciente?

- ☐ a. Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis
- ☐ b. Solicitar prueba de IGRA (ensayo de liberación de interferón gamma)
- ☐ c. Realizar lavado bronquioalveolar
- ☐ d. Solicitar TAC de tórax
- ☐ e. Iniciar tratamiento antituberculoso

Manejo de la Tuberculosis: El paciente presenta un cuadro clínico y radiográfico compatible con una infección tuberculosa. Si bien las baciloscopías resultaron negativas, los antecedentes epidemiológicos (el marido tiene tuberculosis activa), sumados a la clínica y la radiografía, son suficientes para iniciar el tratamiento antituberculoso de inmediato. Se puede solicitar una PCR para Mycobacterium tuberculosis para confirmar el diagnóstico, pero no es necesario esperar los resultados para comenzar el tratamiento, ya que la probabilidad es muy alta y se trata de una patología grave. El quantiferón y los IGRAs sirven para el diagnóstico de tuberculosis latente y no para la sospecha de tuberculosis activa.

La respuesta correcta es: Iniciar tratamiento antituberculoso

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 20 años consulta por aumento de volumen en el cuello de 2 meses de evolución, asociado, en el último tiempo, a leve malestar general, fiebre ocasional y sudoración nocturna. Al examen físico, se palpan adenopatías submandibulares y cervicales bilaterales de consistencia aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Tuberculosis ganglionar
- ☐ b. Linfoma
- ☐ c. Infección por VIH
- ☐ d. Sarcoidosis
- ☐ e. Mononucleosis infecciosa

Linfoma de Hodgkin: La historia clínica sugiere un linfoma, probablemente un linfoma de Hodgkin, debido a la presencia de síntomas B y la edad. Sin embargo, estos síntomas no son específicos de este tipo de cáncer. El diagnóstico definitivo se realiza mediante una biopsia ganglionar excisional.

La respuesta correcta es: Linfoma

Pregunta 17

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una niña de 7 años presenta un cuadro de 4 días de evolución con fiebre alta, tos con expectoración mucopurulenta, a lo que se agregó dolor torácico con la inspiración profunda y, recientemente, también dolor abdominal y deposiciones diarreicas. Al examen físico, está febril con T°: 38,8°C, con frecuencia cardíaca: 110x' y, en su examen cardiopulmonar se ausculta murmullo pulmonar disminuido bilateralmente, abolido en la base derecha, con crépitos en esa zona. El examen abdominal muestra dolor difuso a la palpación profunda, sin signos peritoneales y se ausculta aumento de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál de los siguientes es el examen de elección para iniciar el estudio?

- ☐ a. Ecografía abdominal
- ☐ b. Videotoracoscopia
- ☐ c. Radiografía de tórax lateral en decúbito lateral
- ☐ d. TAC de tórax
- ☐ e. Radiografía de tórax anteroposterior y lateral

Neumonía y Dolor Abdominal: El paciente presenta un cuadro clínico de neumonía clásica. Es importante tener en cuenta que la neumonía puede manifestarse con dolor abdominal y otros síntomas abdominales. Por lo tanto, el examen inicial a realizar es una radiografía de tórax anteroposterior y lateral.

La respuesta correcta es: Radiografía de tórax anteroposterior y lateral

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 31 años con 28 semanas de gestación y antecedente de asma severo, presenta un cuadro de cefalea intensa asociada a tinitus. Al examen físico se constata presión arterial de 160/110 mmHg. El registro fetal muestra una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto. No tiene focalidad neurológica. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada para esta paciente?

- ☐ a. Administrar labetalol endovenoso
- ☐ b. Administrar nifedipino oral
- ☐ c. Administrar sulfato de magnesio endovenoso
- ☐ d. Solicitar TAC de cerebro
- ☐ e. Administrar misoprostol intrarrectal

Manejo de Crisis Hipertensiva en el Embarazo: La paciente presenta una crisis hipertensiva del embarazo. El tratamiento habitual en estos casos es con labetalol intravenoso. Sin embargo, en esta paciente en particular, el uso de betabloqueadores está absolutamente contraindicado debido a su historial de asma severo. La alternativa de tratamiento en este caso es el nifedipino, que generalmente se administra por vía oral.

La respuesta correcta es: Administrar nifedipino oral

Pregunta 19

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 27 años consulta por dolor abdominal de un mes de evolución, asociado a diarrea y baja de peso de 6 kg. En algún momento, presentó deposiciones sanguinolentas. Se solicita una tomografía axial computarizada (TAC), que muestra engrosamiento del íleon distal y del ciego, sin masas. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio diagnóstico?

- ☐ a. Parasitológico de deposiciones
- ☐ b. Endoscopia digestiva alta
- ☐ c. Colonoscopia
- ☐ d. Enteroscopia
- ☐ e. Enteroclis por TAC

Enfermedad de Crohn: La clínica de la paciente es compatible con una enfermedad inflamatoria intestinal. Además, la TAC muestra un compromiso del intestino delgado, lo que sugiere una enfermedad de Crohn. En las enfermedades inflamatorias intestinales, el diagnóstico definitivo se realiza mediante una colonoscopia.

La respuesta correcta es: Colonoscopia

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 55 años con diabetes mellitus mal controlada con metformina consulta por disestesias y sensación de aumento de volumen o edema en ambas manos, de predominio nocturno, que disminuyen con el movimiento y ceden al iniciar sus actividades diarias. El examen físico muestra movilidad y sensibilidad conservadas, con leve atrofia de la eminencia tenar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Neuropatía diabética simétrica sensitiva
- ☐ b. Contractura de Dupuytren
- ☐ c. Atrapamiento de los dedos flexores de la mano
- ☐ d. Artritis reumatoide
- ☐ e. Síndrome del túnel carpiano

Síndrome del Túnel Carpiano vs. Neuropatía Diabética: El paciente presenta un cuadro clínico compatible con síndrome del túnel carpiano. Se asocia a diabetes. El dolor nocturno y la desaparición de los síntomas con las actividades de la vida diaria son características distintivas del síndrome del túnel carpiano. En contraste, la neuropatía diabética simétrica sensitiva suele afectar primero a los pies y solo en etapas más avanzadas a las manos.

La respuesta correcta es: Síndrome del túnel carpiano

Pregunta 21

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 80 años consulta por dificultades para comer, caracterizada por disfagia alta intermitente, tanto para alimentos sólidos como líquidos. Refiere, además, regurgitación frecuente de alimentos, halitosis y una pérdida de peso de 4 kg en los últimos meses. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Acalasia esofágica
- ☐ b. Cáncer de esófago
- ☐ c. Divertículo de Zenker
- ☐ d. Esclerosis sistémica con compromiso esofágico
- ☐ e. Reflujo gastroesofágico

Divertículo de Zenker: El paciente presenta un cuadro clínico característico de un divertículo de Zenker, un tipo de divertículo esofágico. La halitosis y la disfagia alta, que suele ser intermitente y varía según el grado de represión del divertículo, son características de esta patología.

La respuesta correcta es: Divertículo de Zenker

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 40 años se realiza una mamografía que reporta BIRADS 0 (insuficiente). Posteriormente, se realiza una ecografía mamaria con resultado BIRADS 2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Repetir la mamografía en 6 meses
- ☐ b. Repetir la ecotomografía mamaria en 6 meses
- ☐ c. Solicitar una mamografía con compresión lateralizada
- ☐ d. Solicitar una resonancia magnética nuclear de mamas
- ☐ e. Realizar biopsia estereotáxica

Manejo de Mamografías BIRADS 0: Las mamografías clasificadas como BIRADS 0 requieren estudios adicionales para su evaluación, siendo la ecografía mamaria la técnica de elección. En el caso de las ecografías mamarias BIRADS 2, la lesión es benigna. Sin embargo, se recomienda repetir la ecografía en 6 meses para confirmar su estabilidad. Un ejemplo de lesión BIRADS 2 en la ecografía es el fibroadenoma, que requiere de seguimiento en 6 meses.

La respuesta correcta es: Repetir la ecotomografía mamaria en 6 meses

Pregunta 23

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 23 años presenta un cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por ánimo bajo, tristeza, disminución de sus actividades, asociado a hipersomnias diurnas y aumento de peso de 5 kg en poco tiempo. Además, refiere dificultades de concentración en sus actividades educacionales. Tiene antecedentes de tres episodios similares en los últimos años y su hermana refiere que también ha presentado dos episodios en los cuales ha tenido periodos con mucho ánimo y aumento de la energía, incurriendo en gastos excesivos y desarrollando múltiples proyectos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Trastorno de personalidad histriónico
- ☐ b. Trastorno afectivo bipolar
- ☐ c. Trastorno por déficit atencional hiperactivo
- ☐ d. Trastorno de personalidad limítrofe
- ☐ e. Depresión atípica

Trastorno Afectivo Bipolar: La paciente presenta un cuadro inicial que podría interpretarse como una depresión atípica, con aumento de peso e hipersomnias. Sin embargo, el antecedente de episodios maníacos previos apunta a trastorno afectivo bipolar. En el contexto de un trastorno bipolar, la depresión debe tratarse con antipsicóticos atípicos como la risperidona o el aripiprazol, y eventualmente con estabilizadores del ánimo como el litio o el ácido valproico.

La respuesta correcta es: Trastorno afectivo bipolar

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente usuaria de anticonceptivos y con antecedentes familiares de hipotiroidismo, consulta por aumento de volumen en el cuello. Al examen físico, la tiroides se palpa aumentada de tamaño, sin nódulos. Los exámenes revelan una TSH: 2,0 UI/L, T4: 14,0 ug/dl (valor normal: 4,5 a 9,5), anticuerpos antitiroglobulina: 48 UI/ml (valor normal: <35) y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea: 320 UI/ml (valor normal: <35). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Solicitar T4 libre
- ☐ b. Solicitar ecografía tiroidea
- ☐ c. Solicitar una cintigrafía tiroidea
- ☐ d. Realizar control de TSH y T4 en un año
- ☐ e. Realizar biopsia tiroidea por punción

Tiroiditis de Hashimoto Eutiroides: El diagnóstico más probable en esta paciente es tiroiditis de Hashimoto, ya que presenta bocio y elevación de los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Si bien la T4 está elevada, esto se debe al uso de anticonceptivos, que elevan la TBG. En las pacientes que utilizan anticonceptivos, se debe utilizar la T4 libre en lugar de la T4 total. El valor normal de la TSH descarta la presencia de hipertiroidismo. El manejo de la tiroiditis de Hashimoto eutiroides, como en este caso, consiste en realizar un control frecuente con pruebas tiroideas anuales para detectar y tratar precozmente el eventual hipotiroidismo.

La respuesta correcta es: Realizar control de TSH y T4 en un año

Pregunta 25

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 27 años, usuaria de dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, consulta por flujo genital de mal olor que empeora después de tener relaciones sexuales. Al examen físico se observa cuello uterino normal y secreción vaginal de color gris. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Retirar el dispositivo intrauterino bajo cobertura antibiótica
- ☐ b. Indicar fluconazol vía oral
- ☐ c. Iniciar doxiciclina vía oral
- ☐ d. Realizar VDRL a la paciente y a su pareja.
- ☐ e. Indicar metronidazol por vía oral

Vaginosis Bacteriana y DIU: La paciente presenta un cuadro clínico compatible con vaginosis bacteriana, la cual se trata con metronidazol vía oral o clindamicina tópica. A diferencia del proceso inflamatorio pélvico que no responde al tratamiento antibiótico después de 48 horas, en la vaginosis bacteriana no es necesario retirar el DIU.

La respuesta correcta es: Indicar metronidazol por vía oral

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 40 años con antecedente de cirugía bariátrica presenta un cuadro de 24 horas de dolor abdominal muy intenso, tipo cólico, asociado a múltiples episodios de vómitos alimentarios. Al examen físico presenta T°: 38,5°C, frecuencia cardíaca regular a 108 lpm, presión arterial de 100/60 mmHg. Al examen abdominal, se observa abdomen distendido, doloroso a la palpación, con resistencia muscular difusa, se ausculta bazuqueo intestinal y ruidos hidroaéreos intensos.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Íleo mecánico por bridas
- ☐ b. Perforación intestinal
- ☐ c. Isquemia mesentérica
- ☐ d. Colitis isquémica
- ☐ e. Gastroenteritis aguda

Obstrucción Intestinal por Bridas: El paciente presenta un cuadro clínico de obstrucción intestinal, caracterizado por la tríada de dolor cólico, vómitos y distensión abdominal. En este caso, la causa más probable de la obstrucción son las bridas, debido al antecedente de cirugía abdominal previa.

La respuesta correcta es: Íleo mecánico por bridas

Pregunta 27

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 82 años con antecedente de colecistectomía hace 5 años, consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por ictericia y coluria, asociado a decaimiento. Niega dolor, pero refiere que ha bajado de peso en los últimos meses. Sus signos vitales son normales y se observa en buen estado general, orientada e hidratada, con ictericia de piel y escleras. Al examen abdominal no se palpan masas ni signos peritoneales. Los exámenes de laboratorio revelan fosfatasas alcalinas: 422 UI/L, GGT: 322 UI/L, GOT: 110 UI/L, GPT: 75 UI/L, protrombinemia: 90% y albúmina sérica: 3,1 g/dl.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Cáncer de páncreas
- ☐ b. Coledocolitiasis residual
- ☐ c. Cáncer de duodeno
- ☐ d. Cáncer de la vía biliar
- ☐ e. Colangitis esclerosante primaria

Sospecha de Cáncer de Vía Biliar: La sospecha clínica en este paciente es de un cáncer que obstruye la vía biliar, considerando su edad y la presencia de ictericia sin dolor. El antecedente de colecistectomía previa hace poco probable un cáncer de vesícula biliar, pero aún puede tener uno de vía biliar o colangiocarcinoma.

La respuesta correcta es: Cáncer de la vía biliar

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 58 años presenta dolor en el hombro derecho desde hace 4 meses, que aumenta con la actividad física. Refiere que es intenso, con EVA 6/10, empeorando en la noche. Al examen físico, la movilidad pasiva está conservada, pero presenta limitación en la movilidad activa, especialmente para elevar el brazo por encima del hombro y en los movimientos de rotación interna. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Artrosis acromioclavicular
- ☐ b. Artrosis glenohumeral
- ☐ c. Síndrome del manguito rotador
- ☐ d. Capsulitis adhesiva
- ☐ e. Tendinopatía bicipital

Síndrome de Manguito Rotador: El paciente presenta un síndrome de manguito rotador clásico. La capsulitis adhesiva, en cambio, se caracteriza por la limitación tanto de la movilidad pasiva como activa.

La respuesta correcta es: Síndrome del manguito rotador

Pregunta 29

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 68 años, nulípara, con antecedente de menopausia a los 50 años, consulta debido a sangrado genital intermitente de 2 meses de evolución, con cuantía variable. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra un endometrio de 13 mm de grosor de aspecto heterogénea, con áreas microquísticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Hiperplasia endometrial
- ☐ b. Miomatosis endometrial
- ☐ c. Atrofia endometrial
- ☐ d. Pólipo endometrial
- ☐ e. Cáncer de endometrio

Hiperplasia Endometrial: El endometrio grueso e irregular es una característica tanto de la hiperplasia endometrial como del cáncer de endometrio. Sin embargo, la descripción de un aspecto heterogéneo con áreas microquísticas se observa con mayor frecuencia en la hiperplasia endometrial, por lo que esta es la respuesta correcta. Eso sí, la conducta es realizar una biopsia de endometrio para confirmar el diagnóstico y descartar el cáncer. La hiperplasia simple se trata con progestágenos. La hiperplasia atípica, en cambio, se trata con histerectomía.

La respuesta correcta es: Hiperplasia endometrial

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 65 años, menopáusica hace 15 años, sufrió una fractura de muñeca derecha hace un año y recientemente sufrió una fractura de cadera derecha. La densitometría ósea muestra un T-score de -3 en la zona lumbar, -2.7 en la cadera derecha y -2.5 en la cadera izquierda. Además de indicar una adecuada ingesta de calcio y vitamina D, ¿cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

- ☐ a. Alendronato 70 mg semanal
- ☐ b. Risedronato 150 mg semanal
- ☐ c. Ácido zoledrónico 5 mg cada 6 meses
- ☐ d. Terapia de reemplazo hormonal
- ☐ e. Denosumab endovenoso

Tratamiento de la Osteoporosis: El tratamiento de la osteoporosis generalmente incluye la ingesta de calcio, vitamina D y bifosfonatos. No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los distintos tipos de bifosfonatos, y la principal diferencia entre ellos radica en la periodicidad con la que se administran. El alendronato se administra semanalmente, el ibandronato mensualmente, y el ácido zoledrónico semestral o anualmente. Sin embargo, en casos de osteoporosis severa, definida por un T-score menor a -3 o por la presencia de fracturas osteoporóticas (como en este caso), se recomienda el tratamiento con anabólicos óseos, en lugar de bifosfonatos (teriparatida y romosozumab). El denosumab es una opción aceptable en estos casos. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la acción de los osteoclastos.

La respuesta correcta es: Denosumab endovenoso

Pregunta 31

Sin contestar

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones representa la mejor estrategia para la detección temprana del cáncer testicular en la población en riesgo?

- ☐ a. Niveles plasmáticos de alfafetoproteína
- ☐ b. Establecer consultorios especializados para pacientes con dolor testicular
- ☐ c. Implementar campañas de autoexamen testicular
- ☐ d. Realizar ecografías testiculares como prueba de detección
- ☐ e. Solicitar niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana

Screening de Cáncer Testicular: La ecografía testicular, aunque útil para diagnosticar tumores, no se recomienda como prueba de screening. Las guías internacionales se enfocan en el autoexamen testicular, aunque la evidencia de su utilidad es limitada.

La respuesta correcta es: Implementar campañas de autoexamen testicular

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un hombre de 21 años experimenta dificultades para realizar presentaciones en público, que han afectado su rendimiento académico. Además, refiere enrojecimiento facial y torpeza en situaciones sociales. Recientemente no pudo terminar una presentación oral frente a su curso, ya que refiere que su mente se quedó en blanco en un momento. Todo esto le ha generado angustia y tristeza. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Fobia específica
- ☐ b. Agorafobia
- ☐ c. Trastorno de ansiedad generalizada
- ☐ d. Trastorno de ansiedad social
- ☐ e. Trastorno de personalidad evitativa

Fobia Social: El cuadro clínico presentado describe una fobia social, también llamada trastorno de ansiedad social.

La respuesta correcta es: Trastorno de ansiedad social

Pregunta 33

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un recién nacido presenta cianosis a las 2 horas de vida, que aumenta con el llanto y se localiza en boca, manos y pies. Al nacer presentó Apgar 9-9 y su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es la prueba más adecuada para iniciar el estudio diagnóstico?

- ☐ a. Prueba de hiperoxia
- ☐ b. Ecocardiograma
- ☐ c. Doppler cervical
- ☐ d. Radiografía de tórax
- ☐ e. TAC de tórax

Screening de Cardiopatías Congénitas: El ecocardiograma es la prueba ideal para diagnosticar cardiopatías congénitas. Sin embargo, se recomienda iniciar con un screening de oximetría de pulso. Si la saturación es menor al 95%, se procede con la prueba de hiperoxia (oxígeno al 100% por 10 minutos). Si la saturación o la presión arterial de oxígeno en sangre arterial aumenta, la cianosis es probablemente de origen respiratorio. Si no hay cambios o permanece baja, se sospecha una cardiopatía congénita cianótica u otra causa de cortocircuito o shunt.

La respuesta correcta es: Prueba de hiperoxia

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 43 años, con antecedentes de tabaquismo y consumo excesivo de alcohol, consulta por un cuadro de 5 días de evolución caracterizado por sensación febril, tos con expectoración mucopurulenta y en ocasiones hemoptoica. Al examen físico, se observa delgado, con T°: 38,5°C, frecuencia cardíaca: 100x', PA: 118/76 mmHg, saturación arterial de 95% y frecuencia respiratoria: 17x'. Su examen pulmonar muestra crepitaciones y algunos estertores bilaterales y su examen cardíaco muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación:



¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Realizar una prueba de quantiferón para tuberculosis
- ☐ b. Realizar una broncoscopia
- ☐ c. Solicitar una prueba de elisa de cuarta generación para VIH
- ☐ d. Realizar una toracocentesis diagnóstica y evacuadora
- ☐ e. Solicitar una tomografía axial computarizada (TAC) de tórax

Derrame Pleural: El cuadro clínico sugiere una tuberculosis activa en la infección inicial o bien una neumonía bacteriana, en ambos casos con derrame pleural izquierdo visible en la radiografía. La toracentesis diagnóstica y evacuadora es la medida más importante. Se debe solicitar PCR para *Mycobacterium tuberculosis* o, al menos, baciloscopías. El quantiferón-TB solo es útil para la tuberculosis latente, que no se sospecha en este caso al haber síntomas.

La respuesta correcta es: Realizar una toracocentesis diagnóstica y evacuadora

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un lactante de 6 meses presenta ocho hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

- ☐ a. Solicitar ecografía abdominal
- ☐ b. Iniciar propranolol oral
- ☐ c. Iniciar corticoides intralesionales
- ☐ d. Solicitar una resonancia magnética nuclear de cerebro
- ☐ e. Solicitar estudio de neurofibromatosis

Hemangiomas Infantiles: La presencia de múltiples hemangiomas infantiles obliga a descartar hemangiomas viscerales con una ecografía abdominal. El propranolol oral es el tratamiento de elección para los hemangiomas complicados o deformantes.

La respuesta correcta es: Solicitar ecografía abdominal

Pregunta 36

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 32 años consulta por la idea recurrente de que debe limpiar sus utensilios de alimentación para evitar adquirir una infección intestinal. Refiere que se cepilla los dientes durante 15 minutos y luego se enjuaga la boca por 10 minutos más. Reconoce que a veces quiere dejar de hacerlo, pero no puede evitarlo. Como antecedente, sufrió de leucemia aguda a los 7 años, siendo manejado con quimioterapia y logrando la curación de la enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Manía aguda
- ☐ b. Trastorno por descontrol de impulsos
- ☐ c. Trastorno de personalidad
- ☐ d. Esquizofrenia
- ☐ e. Trastorno obsesivo compulsivo

Trastorno Obsesivo-Compulsivo: El cuadro clínico describe un trastorno obsesivo-compulsivo clásico, con obsesión por la contaminación y compulsión por la limpieza.

La respuesta correcta es: Trastorno obsesivo compulsivo

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 70 años consulta por disnea de medianos esfuerzos progresiva, asociada a ortopnea. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 78 lpm, presión arterial: 130/80 mmHg, examen pulmonar con murmullo vesicular conservado y presencia de crépitos bibasales, examen cardíaco con ritmo irregular en dos tiempos, con presencia de soplo diastólico. Se palpa el choque de la punta en el quinto espacio intercostal línea medioclavicular y se observa edema en extremidades inferiores con signo de la fóvea. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Estenosis aórtica
- ☐ b. Estenosis pulmonar
- ☐ c. Estenosis mitral
- ☐ d. Insuficiencia aórtica
- ☐ e. Insuficiencia pulmonar

Estenosis Mitral: El cuadro clínico es compatible con estenosis mitral. Se recomienda repasar la semiología cardíaca.

La respuesta correcta es: Estenosis mitral

Pregunta 38

Sin contestar

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes instituciones es la encargada de supervisar el funcionamiento del sistema de salud público y privado en Chile, fiscalizar a FONASA y a las instituciones previsionales de salud, y velar por el cumplimiento de las garantías GES?

- ☐ a. Instituto de Salud Pública
- ☐ b. Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud
- ☐ c. Ministerio de Salud, por medio de la Subsecretaría de Salud Pública
- ☐ d. Superintendencia de Salud
- ☐ e. Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Superintendencia de Salud: La Superintendencia de Salud es el organismo encargado de las funciones mencionadas en la pregunta.

La respuesta correcta es: Superintendencia de Salud

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 35 años con antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica previa tratada, consulta por un cuadro de 24 horas de evolución de sangrado genital escaso y dolor abdominal bajo asociado a un test de embarazo en orina positivo. Refiere 6 semanas de amenorrea. Al examen físico sus signos vitales muestran FC: 82x', PA: 110/74 mmHg y se encuentra en buenas condiciones generales, sin alteraciones en el examen abdominal. Su especuloscopia muestra escaso sangrado uterino. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- ☐ a. Solicitar ecografía y niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana
- ☐ b. Control con ecografía en 7 días
- ☐ c. Realizar una laparoscopia exploradora inmediata
- ☐ d. Realizar legrado uterino.
- ☐ e. Solicitar una resonancia magnética nuclear de pelvis

Metrorragia en el Embarazo: En una paciente con metrorragia en la primera mitad del embarazo (por las 6 semanas de amenorrea con prueba de embarazo positiva), se debe solicitar una ecografía para diferenciar entre aborto, embarazo ectópico y mola. Los niveles de gonadotropina coriónica humana ayudan a identificar embarazos ectópicos, con valores superiores a 3.500 UI/L y ecografía negativa para gestación intrauterina. La paciente presenta estabilidad hemodinámica, lo que reduce la sospecha de un embarazo ectópico roto.

La respuesta correcta es: Solicitar ecografía y niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana

Pregunta 40

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 25 años, sin antecedentes de importancia, consulta por mastalgia bilateral de 5 días de evolución. Al examen físico, se observa galactorrea bilateral al comprimir los pezones. Su FUR fue hace 12 días y no toma medicamentos. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio?

- ☐ a. Subunidad beta de gonadotropina coriónica humana en plasma
- ☐ b. Prolactinemia
- ☐ c. Resonancia magnética de silla turca
- ☐ d. Ecotomografía mamaria
- ☐ e. Mamografía

Galactorrea y Amenorrea: Ante una paciente con galactorrea y amenorrea, lo primero es descartar embarazo. Luego, se busca hiperprolactinemia, cuya causa principal son los medicamentos (no en este caso, en que no utiliza medicamentos) y, luego, los adenomas hipofisarios. La última regla fue hace 12 días, lo que reduce la probabilidad de embarazo. Sin embargo, es fundamental descartarlo con una prueba de gonadotropina coriónica humana en plasma.

La respuesta correcta es: Subunidad beta de gonadotropina coriónica humana en plasma

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente es hospitalizado durante 10 días por causa de una neumonía neumocócica adquirida en la comunidad. Algunos días después de haber sido dado de alta, presenta diarrea líquida abundante, con 5 a 6 evacuaciones al día, asociada a dolor abdominal, malestar general y febrículas hasta 37.3°C. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

- ☐ a. Colonoscopia
- ☐ b. Parasitológico ampliado de deposiciones
- ☐ c. Coprocultivo
- ☐ d. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para *Clostridium difficile*
- ☐ e. Ecografía abdominal

Diarrea por Clostridioides (*Clostridium*) *Difficile*: Tras recibir antibióticos, se debe descartar diarrea por Clostridioides *difficile* mediante PCR, que ha reemplazado las pruebas de toxinas A y B en heces.

La respuesta correcta es: Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para *Clostridium difficile*

Pregunta 42

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un lactante de 12 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea y fiebre hasta 38,8°C de 24 horas de evolución, a lo que hoy se agregó dificultad respiratoria. Al examen físico presenta estridor inspiratorio, que aumenta con el llanto, asociado a retracción intercostal moderada. Su saturación de oxígeno es 94% y, al examen pulmonar se ausculta murmullo pulmonar conservado bilateral con transmisión de ruidos desde la vía aérea superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Laringitis aguda obstructiva
- ☐ b. Neumonía atípica
- ☐ c. Neumonía bilateral
- ☐ d. Asma del lactante
- ☐ e. Neumonitis viral

Laringitis Aguda Obstructiva: El caso describe una laringitis aguda obstructiva clásica, con un cuadro gripal seguido de síntomas obstructivos, incluyendo estridor laríngeo.

La respuesta correcta es: Laringitis aguda obstructiva

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente consulta al servicio de urgencias por disnea y malestar de 2 horas de evolución. Refiere un viaje reciente en avión desde Europa hace 12 horas y es usuaria de anticonceptivos orales. Al examen físico, tiene presión arterial: 110/70 mmHg, frecuencia cardíaca: 100x' y saturación arterial de oxígeno: 90%, su auscultación cardiopulmonar es normal, al igual que el resto de su examen físico. Se solicita un electrocardiograma que muestra taquicardia sinusal a 120 latidos por minuto. ¿Cuál es el examen de elección para continuar con el estudio?

- ☐ a. Dímero D
- ☐ b. Ecocardiograma
- ☐ c. AngioTAC de tórax
- ☐ d. Péptido natriurético cerebral
- ☐ e. Electrocardiograma Holter de 24 horas

Score de Wells para TEP: La paciente presenta dos criterios del score de Wells para TEP: taquicardia y cuadro clínico sugestivo de TEP sin otro diagnóstico más probable. Esto implica un riesgo intermedio que obliga a descartar la condición con imágenes. El angioTAC de tórax es la prueba de elección, ya que la paciente está hemodinámicamente estable. La otra forma de ver el caso es directamente ver que tiene un cuadro clínico compatible, con factores de riesgo y alteraciones en el examen físico, lo que da una probabilidad al menos intermedia de TEP, lo que obliga a solicitar un angioTAC en lugar de sólo un dímero D.

La respuesta correcta es: AngioTAC de tórax

Pregunta 44

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 17 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor abdominal tipo cólico, que se ha exacerbado en las últimas 3 semanas y que está asociado a deposiciones diarreicas intermitentes, las que dice haber tenido desde los 15 años, con aumento de la frecuencia en el último mes. Al examen físico presenta inyección ciliar bilateral, sus signos vitales se encuentran dentro de los parámetros normales; al examen abdominal presenta dolor leve a la palpación abdominal sin signos peritoneales y se detecta una masa palpable en el flanco derecho. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 31%, hemoglobina: 10.2 g/dL, VCM: 76 fL, HCM: 27 pg, glóbulos blancos: 10.000 por mm³, plaquetas: 320.000 por mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Enfermedad de Crohn
- ☐ b. Enfermedad celíaca
- ☐ c. Colitis parasitaria
- ☐ d. Colitis ulcerosa
- ☐ e. Cáncer de colon

Enfermedad de Cröhn: El cuadro clínico es compatible con enfermedad inflamatoria intestinal con síntomas extraintestinales (oculares). La presencia de una masa sugiere fuertemente enfermedad de Cröhn. Si hubiese sido un adulto mayor, se hubiese sospechado un cáncer de colon.

La respuesta correcta es: Enfermedad de Crohn

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 79 años, con antecedente de cáncer de pulmón en espera de tratamiento, presenta un cuadro de 5 días de malestar general, disnea y episodios de pérdida de conocimiento de pocos segundos de duración, con recuperación completa. El examen físico muestra presión arterial: 80/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 110x' regular, cuello con ingurgitación yugular a 50 grados. El examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin otros ruidos agregados y la auscultación cardíaca es difícil de realizar, ya que los ruidos cardíacos se encuentran apagados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Tromboembolismo pulmonar
- ☐ b. Taponamiento cardíaco
- ☐ c. Derrame pleural
- ☐ d. Síndrome de la vena cava superior
- ☐ e. Insuficiencia tricuspídea

Taponamiento Cardíaco: Aunque el antecedente de cáncer, la hipotensión y la disnea sugieren un tromboembolismo pulmonar, la disminución de la intensidad de los ruidos cardíacos apunta a derrame pericárdico con taponamiento, también compatible con el antecedente de cáncer y el resto de la clínica. Se recomienda revisar el resumen de semiología cardíaca.

La respuesta correcta es: Taponamiento cardíaco

Pregunta 46

Sin contestar

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al indicador de letalidad por influenza?

- ☐ a. Número de casos de influenza / Número de fallecidos por influenza
- ☐ b. Número de fallecidos por influenza / Población general
- ☐ c. Número de casos de influenza / Población general
- ☐ d. Número de fallecidos por influenza / Número de casos de influenza
- ☐ e. Número de casos de influenza / Población expuesta

Letalidad: La letalidad se define como la probabilidad de morir si se contrae una enfermedad. Se calcula dividiendo el número de muertes causadas por la enfermedad entre el total de casos de esa enfermedad.

La respuesta correcta es: Número de fallecidos por influenza / Número de casos de influenza

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 60 años, gran fumador y con antecedentes de consumo excesivo de alcohol, hasta hace 6 meses en que suspendió el cigarrillo y la ingesta de alcohol, consulta por episodios de dolor abdominal epigástrico intenso, asociado a vómitos alimentarios. Refiere también episodios de diarrea abundante, que han ido en aumento. Se solicitan exámenes, entre los que muestra hemograma con hematocrito: 39%, blancos: 9.000 por mm³, plaquetas: 250.000 por mm³; glicemia de ayuno: 122 mg/dL, lipasa plasmática: 210 UI/L, amilasa plasmática: 90 UI/L, fosfatasa alcalina: 210 UI/L, GOT: 32 UI/L, GPT: 40 U/L y GGT: 70 UI/L. Se realiza ecografía abdominal, que se describe como "ventana ecográfica insuficiente por meteorismo". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Pancreatitis aguda
- ☐ b. Colecistitis aguda
- ☐ c. Cáncer de páncreas
- ☐ d. Coledocolitiasis
- ☐ e. Pancreatitis crónica

Pancreatitis Crónica: El caso describe una pancreatitis crónica con complicaciones típicas como diabetes (tiene glicemia de ayuno alterada y no aún diabetes) y síndrome de mala absorción. Se caracteriza por dolor abdominal, generalmente después de ingerir alimentos o alcohol. La causa más frecuente es el alcoholismo.

La respuesta correcta es: Pancreatitis crónica

Pregunta 48

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 68 años con diagnóstico reciente de ateromatosis aórtica y carotídea se realiza un perfil lipídico que muestra: colesterol total: 194 mg/dL, colesterol LDL: 93 mg/dL, HDL: 37 mg/dL y triglicéridos: 287 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

- ☐ a. Iniciar metformina
- ☐ b. Iniciar gemfibrozilo
- ☐ c. Iniciar atorvastatina
- ☐ d. Iniciar ácido nicotínico
- ☐ e. Iniciar ezetimibe

Manejo de Dislipidemia: El paciente presenta ateromatosis aórtica y carotídea, lo que implica un riesgo cardiovascular alto, cuyo objetivo de colesterol LDL es menor a 70. Por tanto, tiene dislipidemia mixta con colesterol LDL alto, colesterol HDL bajo y triglicéridos elevados. La prioridad es el colesterol LDL, por lo que el tratamiento de elección es una estatina, como la atorvastatina. Si los triglicéridos hubiesen estado sobre 500 mg/dL, sería la prioridad y la respuesta sería un fibrato.

La respuesta correcta es: Iniciar atorvastatina

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente con diagnóstico de tuberculosis activa inicia tratamiento antituberculoso con un esquema primario. Al tercer mes de tratamiento, se realiza un control y se observa que las baciloscopías mensuales han permanecido positivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Respuesta clínica esperable
- ☐ b. Fracaso del tratamiento
- ☐ c. Recaída de la tuberculosis
- ☐ d. Infección por micobacterias atípicas
- ☐ e. Aspergilosis pulmonar

Control de Tratamiento de Tuberculosis: Es normal que las baciloscopías se mantengan positivas hasta el tercer mes de tratamiento para la tuberculosis. El diagnóstico de fracaso al tratamiento se realiza con un cultivo positivo a partir del cuarto mes y se sospecha si la baciloscopía continúa positiva hasta el cuarto mes.

La respuesta correcta es: Respuesta clínica esperable

Pregunta 50

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 32 años con antecedente de síndrome hipertensivo del embarazo, a las 32 semanas no logra cifras tensionales normales a pesar de las medidas no farmacológicas. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más adecuado para continuar con el tratamiento?

- ☐ a. Losartán
- ☐ b. Enalapril
- ☐ c. Nifedipino
- ☐ d. Espironolactona
- ☐ e. Doxazosina

Antihipertensivos en el Embarazo: En el embarazo, la mayoría de los antihipertensivos están contraindicados. Los cuatro medicamentos que se pueden usar son alfametildopa, nifedipino (de liberación prolongada o XR), hidralazina y labetalol vía oral (más eficaz, pero su disponibilidad es limitada).

La respuesta correcta es: Nifedipino

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 41 años que trabaja como ejecutiva en una empresa, consulta por cefalea, náuseas y mareos frecuentes y recurrentes. Su examen físico es normal y refiere sentirse estresada y exigida en su trabajo, ya que los resultados de la empresa dependen de su desempeño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Trastorno somatomorfo
- ☐ b. Trastorno disociativo
- ☐ c. Trastorno conversivo
- ☐ d. Trastorno facticio
- ☐ e. Trastorno adaptativo de tipo ansioso

Trastorno Somatomorfo: Este audio describe un trastorno somatomorfo, caracterizado por síntomas físicos sin una causa orgánica subyacente.

La respuesta correcta es: Trastorno somatomorfo

Pregunta 52

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un niño de 7 años es llevado a consulta por prurito anal intenso, mayor en las noches, de 2 semanas de evolución. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, con signos vitales y examen abdominal normales. El examen anal no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada para continuar el estudio de este paciente?

- ☐ a. Colonoscopia
- ☐ b. Examen directo de heces
- ☐ c. Examen parasitológico de deposiciones
- ☐ d. Test de Graham
- ☐ e. Serología para Enterobius vermicularis

Diagnóstico de Enterobiasis: El test de Graham es el examen de elección para diagnosticar enterobiasis (oxiuriasis). Recolecta los huevos del parásito en la zona perianal, utilizando una cinta adhesiva, con mayor efectividad que los análisis parasitológicos convencionales.

La respuesta correcta es: Test de Graham

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente diabético de larga data en tratamiento con empagliflozina 10 mg al día, metformina 1.000 mg cada 8 horas y atorvastatina 20 mg al día, presenta presiones arteriales de 140/90 mmHg y 158/87 mmHg en dos controles diferentes. El resto de su examen físico es normal y trae exámenes, entre los que destaca hemoglobina glicosilada de 6.9%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Iniciar terapia depletiva de potasio
- ☐ b. Iniciar tratamiento antihipertensivo
- ☐ c. Solicitar un monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)
- ☐ d. Iniciar terapia antiagregante plaquetaria
- ☐ e. Iniciar insulina

Hipertensión en Paciente Diabético: Aunque se recomiendan tres tomas de presión arterial o un monitoreo ambulatorio de 24 horas para diagnosticar hipertensión, dos tomas pueden ser suficientes en pacientes diabéticos si hay alta sospecha. El objetivo de presión arterial en estos pacientes es menor a 130/80 mmHg, por lo que está claramente sobre esos valores. El tratamiento inicial recomendado en diabéticos son los antihipertensivos IECA o ARA II.

La respuesta correcta es: Iniciar tratamiento antihipertensivo

Pregunta 54

Sin contestar

Puntúa como 1,00

En el servicio de urgencias, usted evalúa a un niño de 11 años, que se ha comportado muy agresivo, autoagrediendo y golpeando a su madre. Ella refiere que fue citada al colegio, debido a que su hijo tenía malas notas y un comportamiento inapropiado. En la entrevista, el director del colegio le comunicó que había insultado y agredido a sus compañeros y a uno de sus profesores. Tras ser confrontado por su madre, el niño procedió a agredirla y luego se infringió cortes en los brazos. Además, su abuela refiere que el niño miente y le ha robado alcohol y cigarrillos de su tienda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Trastorno disocial
- ☐ b. Trastorno de personalidad limítrofe
- ☐ c. Trastorno del espectro autista
- ☐ d. Trastorno por déficit atencional
- ☐ e. Trastorno oposicionista desafiante

Trastorno de Conducta Disocial: Este audio describe el trastorno de conducta (o disocial), caracterizado por comportamientos agresivos y crueles que violan las normas sociales y legales. Sin un manejo adecuado, puede evolucionar a un trastorno de personalidad antisocial.

La respuesta correcta es: Trastorno disocial

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un hombre de 45 años consulta por ánimo deprimido, anhedonia, alteraciones del sueño y dificultades para concentrarse, los cuales han afectado su desempeño laboral y social durante los últimos 4 meses. No refiere antecedentes de episodios maníacos ni psicosis, pero sí un episodio depresivo mayor hace cinco años, tratado con éxito con fluoxetina. En esta ocasión, se inició tratamiento con escitalopram (20 mg/día) durante 4 semanas, pero no ha mostrado mejoría significativa en sus síntomas. No refiere efectos secundarios importantes con el medicamento y su función tiroidea y niveles de vitamina B12 y ácido fólico son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Aumentar la dosis de escitalopram
- ☐ b. Cambiar el tratamiento a venlafaxina
- ☐ c. Iniciar terapia electroconvulsiva (TEC)
- ☐ d. Agregar un antipsicótico atípico como quetiapina
- ☐ e. Cambiar el tratamiento a fluoxetina

Tratamiento de la Depresión: El tratamiento de elección para un episodio depresivo mayor unipolar son los antidepresivos ISRS, especialmente si el paciente ya ha respondido a este tipo de medicamento. Si no hay respuesta después de 4 semanas, se recomienda cambiar a un antidepresivo dual como venlafaxina o duloxetina.

La respuesta correcta es: Cambiar el tratamiento a venlafaxina

Pregunta 56

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 42 años se realiza una tonometría ocular que informa una presión intraocular de 27 mmHg. Presenta una excavación papilar de 0.7 en el ojo derecho y en la gonioscopia se observa ángulo abierto en todo el contorno del iris. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Retinopatía diabética
- ☐ b. Neuritis óptica
- ☐ c. Glaucoma crónico
- ☐ d. Coriorretinitis
- ☐ e. Degeneración macular relacionada con la edad

Glaucoma Crónico: Una presión ocular mayor a 20 mmHg se considera elevada. La excavación papilar mayor a 0.3 también sugiere glaucoma crónico o de ángulo abierto. La gonioscopia, que examina el ángulo de drenaje del ojo, suele mostrar un ángulo abierto en este tipo de glaucoma.

La respuesta correcta es: Glaucoma crónico

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una lactante de 2 meses de edad presenta un cuadro de fiebre hasta 39°C, de 24 horas de evolución. Es llevada al servicio de urgencias debido a que ha evolucionado con deterioro del estado general y tendencia a la letargia. Al examen físico se observa soporosa, con un llenado capilar de 5 segundos, deshidratada y taquicárdica a 158 latidos por minuto. La temperatura es de 39,3°C. Además de administrar oxígeno, ¿cuál es la primera medida a tomar?

- ☐ a. Administrar solución fisiológica por vía endovenosa
- ☐ b. Administrar bicarbonato por vía endovenosa
- ☐ c. Administrar adrenalina por vía endovenosa
- ☐ d. Administrar hidrocortisona por vía endovenosa
- ☐ e. Administrar glucosa por vía endovenosa

Manejo de Sepsis en Lactantes: En casos de sepsis en lactantes, la prioridad es la reanimación y la administración de antibióticos. Si el lactante presenta shock o signos de deshidratación, la primera medida es la hidratación intravenosa con solución salina.

La respuesta correcta es: Administrar solución fisiológica por vía endovenosa

Pregunta 58

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 47 años con antecedente de neumonía severa por SARS-CoV-2 que requirió intubación y ventilación mecánica por 10 días, evoluciona con dificultad respiratoria progresiva. Al examen físico presenta estridor bifásico, taquicardia a 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria aumentada a 20 respiraciones por minuto y un TAC de cuello que muestra estenosis marcada de la vía aérea a nivel subglótico. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo actual?

- ☐ a. Intubación orotraqueal
- ☐ b. Cricotirotomía
- ☐ c. Traqueostomía
- ☐ d. Oxigenoterapia por mascarilla de no recirculación
- ☐ e. Broncoscopía

Estenosis Subglótica: La estenosis subglótica post-intubación se trata con dilatación con balón mediante broncoscopia en casos estables. Si el paciente está descompensado, como en este caso, se requiere una traqueotomía de urgencia para asegurar la vía aérea. La intubación puede ser difícil por la estenosis severa, y la cricotirotomía es riesgosa porque no se sabe si se realizará por encima o por debajo de la estenosis. Es una pregunta muy discutible y es posible que el Eunacom haya considerado correcta otra opción.

La respuesta correcta es: Traqueostomía

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 45 años presenta un cuadro de cólico renal derecho que es manejado con analgesia. Se realiza una pielotAC, que muestra la presencia de un cálculo de 4 mm en el uréter derecho, el cual se maneja inicialmente con observación. Sin embargo, luego de 4 semanas no ha presentado expulsión del cálculo a pesar de haberse indicado terapia expulsiva con alfabloqueantes hace dos semanas. La pielotAC de control muestra mayor dilatación de la vía urinaria en dicha zona, con presencia del cálculo descrito, de 4 mm en el uréter distal, que se informa con una dureza de 800 unidades de Hounsfield. La creatinina de control está en 1,38 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Mantener terapia farmacológica expulsiva y controlar en 2 semanas
- ☐ b. Realizar la instalación de un catéter "doble J"
- ☐ c. Administrar antibióticos endovenosos
- ☐ d. Realizar una ureteroscopía
- ☐ e. Realizar litotricia (litotripsia) extracorpórea

Manejo de Litiasis Urológica: El manejo de la litiasis urológica varía según el tamaño del cálculo:

Menor a 5 mm: Observación.

Entre 5 y 10 mm: Alfabloqueantes para facilitar la expulsión.

Mayor a 10 mm: Litotricia extracorpórea o ureteroscopía.

La ureteroscopía se prefiere para cálculos en el uréter distal, cálculos muy duros y en casos donde la litotricia extracorpórea está contraindicada (embarazo, alteraciones de la hemostasia). La litotricia extracorpórea (LEC) se prefiere para cálculos de dureza moderada a baja, en el uréter alto o medio, menores a 2 cm, sin contraindicaciones de LEC.

La respuesta correcta es: Realizar una ureteroscopía

Pregunta 60

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 67 años presenta un cuadro de hemiparesia faciobraquiocrural derecha autolimitada hace 7 días, manejada adecuadamente en el hospital. Al examen físico se ausculta un soplo cervical izquierdo, sin otras alteraciones. Su examen neurológico es normal. ¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para realizar el estudio etiológico?

- ☐ a. Ecocardiograma Doppler color
- ☐ b. Angiografía de arterias cerebrales o de cabeza y cuello
- ☐ c. Resonancia magnética de cerebro
- ☐ d. Ecodoppler de carótidas
- ☐ e. TAC de cerebro

Estudio de Fuente Embólica Accidente Isquémico Transitorio: Tras un accidente isquémico transitorio (AIT), se debe buscar la fuente embólica con ecodoppler de carótidas, ecocardiograma y Holter de arritmias. En este caso, la presencia de un soplo en el cuello hace que el ecodoppler de carótidas sea lo más importante. Se maneja con endarterectomía carotídea si la estenosis es mayor al 70%, o mayor al 50% con síntomas como AIT o accidente cerebrovascular.

La respuesta correcta es: Ecodoppler de carótidas

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 70 años sufrió una caída a nivel de tobillo hace un mes, que resultó en una fractura de tobillo derecho. Al examen físico, se encuentra un diámetro de pierna de 33 cm (valor normal: mayor a 31 cm), una prueba de unipedestación con un tiempo de 2 segundos (valor normal: mayor a 5 segundos) y una velocidad de marcha de 0.4 m/s (valor normal: mayor a 0.8 m/s). La densitometría ósea muestra un T-score de -1.9 en la columna lumbar y -2.1 en las caderas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Osteoporosis
- ☐ b. Sarcopenia
- ☐ c. Osteosarcopenia
- ☐ d. Fragilidad
- ☐ e. Alto riesgo de caídas

Osteopenia, Osteoporosis y Sarcopenia: Osteopenia: T-score menor o igual a -1. Osteoporosis: T-score menor o igual a -2.5 (no en este caso). Sarcopenia: Se diagnostica con base en atrofia muscular y/o debilidad muscular, evidenciada en este caso por alteraciones en la velocidad de la marcha y en el test de unipedestación.

La respuesta correcta es: Osteosarcopenia

Pregunta 62

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 68 años con antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión arterial y tabaquismo se encuentra en tratamiento con aspirina, atorvastatina, enalapril 20 mg cada 12 horas, carvedilol 12,5 mg al día, furosemida 40 mg cada 12 horas. Actualmente presenta disnea de pequeños esfuerzos. Al examen físico, tiene frecuencia cardíaca: 65x', presión arterial: 110/70 mmHg, saturación de oxígeno del 96%; en el examen cardiopulmonar se auscultan crépitos pulmonares bibasales y ritmo cardíaco regular en dos tiempos, con un soplo sistólico III/VI. El choque de la punta es palpable en la línea axilar media y presenta edema en los miembros inferiores. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más adecuada para este paciente?

- ☐ a. Agregar losartán
- ☐ b. Agregar hidralazina
- ☐ c. Agregar isosorbide
- ☐ d. Agregar espironolactona
- ☐ e. Agregar amiodarona

Insuficiencia Cardíaca Congestiva: Los medicamentos que aumentan la supervivencia en la insuficiencia cardíaca congestiva son los IECA o ARA II, betabloqueantes (idealmente carvedilol) y espironolactona. El manejo de la patología de base también es fundamental. El losartán no se usa en este caso porque el paciente ya toma enalapril, que cumple la misma función.

La respuesta correcta es: Agregar espironolactona

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un neonato de 21 días de vida, con incremento ponderal deficiente, presenta ictericia que se extiende hasta las piernas. El parto fue por vía vaginal y el embarazo transcurrió sin complicaciones. Su bilirrubina total es de 11,2 mg/dL, con una bilirrubina directa de 7,0 mg/dL. El neonato se encuentra alimentándose con lactancia materna exclusiva y no presenta otros síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Atresia de vías biliares
- ☐ b. Hipotiroidismo congénito
- ☐ c. Ictericia fisiológica
- ☐ d. Ictericia por leche materna
- ☐ e. Síndrome de Gilbert

Ictericia Neonatal Directa: En un caso de ictericia neonatal tardía de predominio directo, el diagnóstico más probable es atresia de vías biliares. Se debe realizar una ecografía abdominal para confirmar el diagnóstico. Se trata con la cirugía de Kasai.

La respuesta correcta es: Atresia de vías biliares

Pregunta 64

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 27 años consulta por ansiedad y ánimo bajo. Refiere antecedentes de problemas de inquietud psicomotora durante la infancia y se considera olvidadiza y desordenada. Refiere que recientemente cambió de puesto de trabajo, presentando errores y dificultades, lo que le ha generado problemas, sintiéndose ansiosa y con ánimo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Trastorno por déficit atencional de tipo hiperactivo
- ☐ b. Trastorno de personalidad
- ☐ c. Trastorno de ansiedad social
- ☐ d. Trastorno de ansiedad generalizada
- ☐ e. Trastorno bipolar

Déficit Atencional en Adultos: Este audio describe un cuadro clínico compatible con déficit de atención del adulto de tipo hiperactivo, con síntomas depresivos y ansiosos.

La respuesta correcta es: Trastorno por déficit atencional de tipo hiperactivo

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 50 años presenta un cuadro clínico de 7 días de evolución, caracterizado por tos con expectoración mucopurulenta abundante y fiebre de hasta 38,7°C. El examen físico muestra disminución del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo pulmonar en la base derecha. La radiografía de tórax muestra signos de condensación en el lado derecho y derrame pleural de tamaño moderado. Se inicia tratamiento con ceftriaxona 2g al día y se realiza toracocentesis, obteniéndose un líquido pleural con 2.000 células/mm³, 85% de polimorfonucleares, colesterol: 70 mg/dL, LDH: 220 U/L, pH: 7.26 y lactato de 6.1 mmol/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Realizar drenaje completo del derrame pleural
- ☐ b. Agregar metronidazol al tratamiento
- ☐ c. Solicitar TAC de tórax
- ☐ d. Solicitar baciloscopías de expectoración
- ☐ e. Realizar broncoscopia y biopsia

Neumonía con Derrame Paraneumónico: El manejo de una neumonía con derrame paraneumónico complicado (por el lactato pleural > 5 mmol/L) incluye drenaje completo del derrame pleural (medida más importante), tubo pleural y metronidazol para cubrir bacterias anaerobias.

La respuesta correcta es: Realizar drenaje completo del derrame pleural

Pregunta 66

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 35 años consulta por prurito en el oído izquierdo, asociado a secreción blanquecina y sensación de oído tapado. A la otoscopía se observa abundante secreción grumosa que cubre parcialmente el tímpano. ¿Cuál es el tratamiento de elección para iniciar el manejo de este paciente?

- ☐ a. Ciprofloxacino tópico
- ☐ b. Fluconazol oral
- ☐ c. Clotrimazol tópico
- ☐ d. Amoxicilina oral
- ☐ e. Ciprofloxacino oral

Otomicosis: El cuadro clínico es característico de la otomicosis por *Candida albicans*, que se trata con antimicóticos tópicos como el clotrimazol.

La respuesta correcta es: Clotrimazol tópico

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un lactante de 8 meses presenta fiebre y rinorrea de 48 horas de evolución, con dificultad respiratoria en las últimas horas. Al examen físico presenta retracción subcostal e intercostal moderada, frecuencia cardíaca: 120x', frecuencia respiratoria: 35x', saturación de oxígeno del 93%. En el examen pulmonar se auscultan sibilancias y crépitos bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Bronquiolitis
- ☐ b. Asma del lactante
- ☐ c. Neumonía multifocal
- ☐ d. Neumonía atípica
- ☐ e. Cardiopatía congénita

Bronquiolitis: Es un caso clásico de bronquiolitis, causada generalmente por el virus respiratorio sincitial (VRS) y que se define como el primer episodio de síndrome bronquial obstructivo en un lactante.

La respuesta correcta es: Bronquiolitis

Pregunta 68

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una niña de 9 años es llevada a urgencias por su madre, debido a dolor mamario derecho. En el examen físico se aprecia mama derecha en desarrollo Tanner II y mama izquierda en Tanner I. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?

- ☐ a. Solicitar niveles plasmáticos de LH y FSH
- ☐ b. Realizar ecografía mamaria
- ☐ c. Controlar en un año
- ☐ d. Realizar resonancia magnética nuclear de mama
- ☐ e. Solicitar una resonancia magnética de silla turca

Telarquia normal: La telarquia (desarrollo mamario) en niñas entre 8 y 13 años se considera un inicio puberal normal. Por tanto, es una niña normal que solo requiere control en un año.

La respuesta correcta es: Controlar en un año

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 32 años, con antecedente de un parto prematuro previo a las 30 semanas de gestación, cursa un nuevo embarazo de 13 semanas. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra una longitud cervical de 28mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Realizar cerclaje cervical
- ☐ b. Iniciar tocolíticos a las 28 semanas
- ☐ c. Indicar progesterona endovaginal y realizar cervicometrías seriadas
- ☐ d. Indicar aspirina oral
- ☐ e. Realizar el control habitual del embarazo

Cuello Uterino Corto: Un cuello uterino corto se define como una longitud cervical menor o igual a 25 mm. La progesterona endovaginal se recomienda en pacientes con cuello uterino corto o con antecedentes de parto prematuro (discutible). Además, el cerclaje se indica si la paciente presenta ambas condiciones.

La respuesta correcta es: Indicar progesterona endovaginal y realizar cervicometrías seriadas

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un niño de 5 años presenta bajo incremento ponderal, con talla y peso menores a -1 desviación estándar para su edad. Se observa una radiografía de mano, que se muestra a continuación.



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Raquitismo
- ☐ b. Displasia ósea
- ☐ c. Osteogénesis imperfecta
- ☐ d. Osteomalacia
- ☐ e. Osteoporosis

Raquitismo: La radiografía muestra un retraso severo en la calcificación de los huesos del carpo y otros huesos de la mano, lo que es compatible con raquitismo causado por deficiencia de vitamina D.

La respuesta correcta es: Raquitismo

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 33 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor durante la penetración en las relaciones sexuales, por lo cual se ha negado a mantenerlas en el último mes. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Trastorno orgásmico femenino
- ☐ b. Trastorno por dolor genito-pélvico/penetración
- ☐ c. Trastorno depresivo mayor
- ☐ d. Trastorno por somatización
- ☐ e. Trastorno del deseo sexual hipoactivo

Dispareunia Superficial: La dispareunia superficial, también conocida como vaginismo o síndrome de dolor genitopélvico penetración, se caracteriza por la contracción involuntaria de los músculos vaginales, causando dolor durante la penetración. Es importante diferenciarla del trastorno orgásmico femenino (ausencia de orgasmo) y el trastorno del deseo sexual hipoactivo (disminución del deseo sexual), que no presentan dolor.

La respuesta correcta es: Trastorno por dolor genito-pélvico/penetración

Pregunta 72

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 19 años presenta disnea, asociada a tos y ocasionalmente sibilancias. Refiere que sus síntomas suelen ser más frecuentes e intensos durante la noche. Ha notado aumento en la intensidad y frecuencia de estos síntomas, desde que adoptó un gato hace un mes. Sus signos vitales son normales, satura 98% a FiO2 ambiente y su examen cardiopulmonar es normal. Se solicita una radiografía de tórax, que resulta normal. Se realiza una espirometría basal y postbroncodilatador, que muestra parámetros dentro de la normalidad. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- ☐ a. IgE sérica total
- ☐ b. TAC de tórax
- ☐ c. Prueba de provocación bronquial con metacolina
- ☐ d. Prueba cutánea para alérgenos inhalados
- ☐ e. Serología para *Mycoplasma pneumoniae*

Diagnóstico de Asma: En un paciente con síntomas compatibles con asma pero sin obstrucción en el examen físico ni en la espirometría, la prueba de provocación bronquial con metacolina se utiliza para confirmar el diagnóstico. Un resultado positivo a la prueba apoya el diagnóstico de asma, que es fundamentalmente clínico.

La respuesta correcta es: Prueba de provocación bronquial con metacolina

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una niña de 7 años con antecedente de leucemia aguda en tratamiento con quimioterapia presenta fiebre de 24 horas de evolución hasta 38,7°C. Su última quimioterapia se realizó hace 10 días. Al examen físico está en buenas condiciones generales, sin alteraciones que identifiquen un foco infeccioso. Tiene una temperatura de 38,5°C y se solicita un hemograma que muestra 800 leucocitos por mm³, con un recuento absoluto de neutrófilos de 450 por mm³, 95.000 plaquetas por mm³ y un hematocrito del 35%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Indicar paracetamol por vía oral más reposo relativo y observación
- ☐ b. Administrar ceftriaxona endovenosa durante la primera hora de atención
- ☐ c. Realizar TAC de tórax y abdomen
- ☐ d. Esperar el resultado del estudio etiológico antes de iniciar antibióticos
- ☐ e. Administrar esquema de cefotaxima y anfotericina B por vía endovenosa

Manejo de la Neutropenia Febril: La neutropenia febril es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato con antibióticos, idealmente dentro de los primeros 30 a 60 minutos del ingreso. El régimen de antibióticos debe cubrir Gram negativos y las guías internacionales recomiendan que se cubra también *Pseudomonas aeruginosa*, siendo cefepime o un carbapenémico las opciones preferidas. En Chile, si se trata de una neutropenia de bajo riesgo (clásico ejemplo los pacientes en quimioterapia con buen aspecto), se acepta tratarlo con cefalosporinas de tercera generación convencionales como la ceftriaxona o el cefotaximo. Los antifúngicos se consideran si hay sospecha de infección fúngica, falta de respuesta a los antibióticos, o fiebre prolongada.

La respuesta correcta es: Administrar ceftriaxona endovenosa durante la primera hora de atención

Pregunta 74

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 67 años, fumador de 40 paquetes/año presenta tos desde hace 4 meses, con expectoración mucosa y ocasionalmente hemoptoica. Además, ha presentado pérdida de 5 kilogramos peso. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 120/80 mmHg y se observa hipocratismo digital. Al examen pulmonar disminución del murmullo pulmonar en el lado derecho y crépitos en la misma zona. ¿Cuál es el examen diagnóstico más adecuado para comenzar el manejo?

- ☐ a. PET-TC
- ☐ b. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para tuberculosis y cultivo para micobacterias
- ☐ c. Fibrobroncoscopia con lavado bronquioalveolar
- ☐ d. TAC de tórax
- ☐ e. Resonancia magnética de tórax

Evaluación Inicial del Cáncer Pulmonar: En un paciente con sospecha de cáncer pulmonar, el examen inicial recomendado es una radiografía de tórax. La tomografía computarizada de tórax también proporciona información muy valiosa y, ante una alta sospecha, se puede pedir como examen inicial. Sin embargo, la radiografía se sigue considerando como el examen inicial.

La respuesta correcta es: TAC de tórax

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 28 años se encuentra en su quinto día postparto, tras el cual presentó atonía uterina que se manejó farmacológicamente. En el examen físico, presenta palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 8.6 g/dL y hematocrito: 25%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Administrar hierro por vía oral
- ☐ b. Administrar hierro por vía endovenosa
- ☐ c. Realizar una transfusión de glóbulos rojos
- ☐ d. Administrar un uterotónico
- ☐ e. Administrar ácido fólico y vitamina B12

Suplementación de Hierro en Anemia Posparto: En una paciente con anemia moderada secundaria a hemorragia posparto, se recomienda la suplementación con hierro para compensar las pérdidas, incluso si no se ha confirmado la deficiencia de hierro. La vía de administración puede ser oral o intravenosa. La vía oral suele ser suficiente para una recuperación completa, por lo que suele ser la de elección, mientras que la vía intravenosa ofrece una recuperación más rápida del hematocrito y es una alternativa del todo aceptable.

La respuesta correcta es: Administrar hierro por vía oral

Pregunta 76

Sin contestar

Puntúa como 1,00

¿Cuál es el cuerpo normativo que regula el ejercicio de la profesión médica en Chile?

- ☐ a. Constitución Política de la República
- ☐ b. Código del Colegio Médico de Chile
- ☐ c. Ley que crea el Ministerio de Salud
- ☐ d. Ley de Derechos y Deberes del Paciente
- ☐ e. Código Sanitario

Alcance del Código Sanitario: El Código Sanitario de Chile regula el ejercicio de las profesiones de la salud, las medidas de prevención y control de enfermedades transmisibles, la protección del medio ambiente en materia sanitaria, los medicamentos y productos farmacéuticos, y las condiciones para el funcionamiento de hospitales, clínicas y salas de procedimiento. También establece la fiscalización por parte de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud.

La respuesta correcta es: Código Sanitario

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 78 años con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es hospitalizada tras desorientarse y agredir a sus cuidadores. En el examen mental se encuentra desorientada en tiempo y espacio, no puede decir los días de la semana en orden inverso y no es capaz de recordar tres palabras que se le dicen en voz alta. Dice ver a su padre en la habitación y, tras el ingreso al hospital, comienza a gritar, exigiendo que la suelten y que se quiere ir del hospital. ¿Cuál es el fármaco de elección para su manejo inicial?

- ☐ a. Clonazepam
- ☐ b. Carbamazepina
- ☐ c. Haloperidol
- ☐ d. Mirtazapina
- ☐ e. Diazepam

Manejo del Delirium: El tratamiento principal del delirium o síndrome confusional agudo es abordar la causa subyacente. El manejo sintomático puede incluir haloperidol en dosis bajas (0,5 a 1 mg) por vía oral o intramuscular.

La respuesta correcta es: Haloperidol

Pregunta 78

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una mujer de 27 años con antecedente de colecistectomía por colelitiasis hace un año, consulta por dolor epigástrico de 24 horas de evolución, de carácter intermitente, que se irradia a la región dorsal. El dolor se acompaña de vómitos alimentarios y coluria el día de hoy. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran bilirrubina total: 3,9 mg/dl, bilirrubina directa: 2,5 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 200 U/L, GPT: 53 U/L, GOT: 45 UI/L, GGT: 58 U/L, albuminemia: 4,2 g/dl y protrombinemia: 100%. La ecografía abdominal muestra una vía biliar intrahepática de características normales y conducto común de 10 mm de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Estenosis postquirúrgica de la vía biliar
- ☐ b. Coledocolitiasis
- ☐ c. Colangitis aguda
- ☐ d. Cáncer de vesícula biliar
- ☐ e. Síndrome de Mirizzi

Coledocolitiasis Residual: La coledocolitiasis residual puede ocurrir hasta un año después de una colecistectomía. Se caracteriza por dolor e ictericia con obstrucción biliar. Las pruebas hepáticas mostrarán un patrón colestásico, y la ecografía puede mostrar una dilatación del conducto biliar común (mayor a 7 mm).

La respuesta correcta es: Coledocolitiasis

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 42 años presenta eliminación de un cálculo en orina, el cual no pudo recuperar para análisis. Se realiza estudio metabólico en orina de 24 horas con calcio, fósforo, citrato y uratos, todos dentro del rango normal, al igual que su perfil bioquímico en sangre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Aumentar la ingesta de agua
- ☐ b. Iniciar alopurinol oral
- ☐ c. Realizar litotricia extracorpórea
- ☐ d. Indicar dieta baja en lácteos
- ☐ e. Indicar dieta rica en vegetales

Prevención de la Litiasis Urinaria: La medida más importante para prevenir la formación de cálculos renales es aumentar la ingesta de agua. Dependiendo del tipo de cálculo y las alteraciones metabólicas, se pueden recomendar medidas adicionales como tiazidas para la hipercalcemia, alopurinol para la hiperuricemia/hiperuricosuria, y una dieta baja en proteínas animales para la hiperoxaluria.

La respuesta correcta es: Aumentar la ingesta de agua

Pregunta 80

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 31 años con diagnóstico reciente de VIH, en tratamiento antirretroviral, se realiza un PPD que resulta 10 mm. Su examen físico es normal y no presenta otras alteraciones. Se observa que tiene una cicatriz de la vacuna BCG en su hombro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Observar evolución
- ☐ b. Solicitar PCR y cultivo para *Mycobacterium tuberculosis*
- ☐ c. Realizar quimioprofilaxis para tuberculosis
- ☐ d. Iniciar tratamiento antituberculoso
- ☐ e. Solicitar ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA) para tuberculosis

Tuberculosis Latente: La prueba de tuberculina (PPD) se utiliza para diagnosticar la tuberculosis latente, aunque los ensayos de liberación de interferón gamma (IGRA) y el quantiferón-TB se han convertido en alternativas más modernas. En pacientes inmunocompetentes, un PPD mayor a 10 mm se considera positivo, mientras que en pacientes con VIH, un PPD mayor a 5 mm es positivo. El tratamiento de la tuberculosis latente se realiza con isoniazida. Actualmente, se prefiere usar el término "tratamiento de la tuberculosis latente", en lugar de "quimioprofilaxis antituberculosa", sin embargo, en la pregunta, se entiende que la opción de tratamiento implica el uso de 4 fármacos para la tuberculosis activa, lo que no está indicado.

La respuesta correcta es: Realizar quimioprofilaxis para tuberculosis

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un niño de 7 años es hospitalizado para manejo quirúrgico de una osteomielitis. El antibiograma informa desarrollo de *Staphylococcus aureus* con el siguiente antibiograma:

Antibiótico	MIC (mg/L)	Interpretación
Ampicilina	>16	Resistente
Oxacilina	>4	Resistente
Ciprofloxacino	>4	Resistente
Clindamicina	1.0	Resistente
Vancomicina	1.0	Sensible
Linezolid	1.0	Sensible
Tetraciclina	≤1	Sensible
Trimetoprim/Sulfametoxazol	≤0.5	Sensible

¿Cuál de los siguientes antibióticos es de elección para el manejo inicial?

- ☐ a. Flucloxacilina
- ☐ b. Cefazolina
- ☐ c. Vancomicina
- ☐ d. Tetraciclina
- ☐ e. Cotrimoxazol

Tratamiento de *Staphylococcus aureus* Resistente a la Meticilina: Un antibiograma que muestra *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM), siendo resistente a los betalactámicos en general, incluyendo oxacilina y cefalosporinas. El tratamiento de elección para el SARM es la vancomicina.

La respuesta correcta es: Vancomicina

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 27 años consulta por un cuadro clínico de un año de evolución caracterizado por astenia, adinamia, malestar general. Además, ha aumentado 8 kg de peso y, en el último mes presenta sensación de frío, constipación y mialgias. Al examen físico presenta lentitud en el lenguaje verbal y razonamiento, piel seca y fría con vitíligo en la cara y manos y alopecia moderada en el cuero cabelludo. Su frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto y su presión arterial, de 130/80 mmHg. Se constata edema bilateral de extremidades inferiores, sin fovea. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- ☐ a. Hemograma - VHS
- ☐ b. Colonoscopia
- ☐ c. Niveles de cortisol
- ☐ d. TAC de cerebro
- ☐ e. TSH

Evaluación del Hipotiroidismo Severo: En un paciente con sospecha de hipotiroidismo severo, la evaluación inicial debe incluir la medición de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y, idealmente, también la T4 libre. El manejo del coma mixedematoso (una complicación grave del hipotiroidismo) consiste en la administración de corticosteroides y levotiroxina intravenosos. En este caso, aún no tiene un coma mixedematoso.

La respuesta correcta es: TSH

Pregunta 83

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 43 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por ánimo bajo, anhedonia, insomnio de conciliación y despertar precoz. Además, ha aumentado de peso y tiene pensamientos negativos e ideas recurrentes negativas sobre sí mismo, sin ideación suicida actual. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento en este paciente?

- ☐ a. Alprazolam
- ☐ b. Sertralina
- ☐ c. Quetiapina
- ☐ d. Carbonato de litio
- ☐ e. Amitriptilina

Depresión: La depresión se trata preferentemente con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como la sertralina. La depresión atípica, por otro lado, presenta síntomas como aumento de peso e hipersomnia y tradicionalmente se trataba con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) como la fenelzina, pero, en la actualidad, los ISRS también se recomiendan como tratamiento de primera línea para la depresión atípica. En este caso es típica, al haber insomnio, en lugar de hipersomnia.

La respuesta correcta es: Sertralina

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente con antecedente de cirrosis hepática por consumo de alcohol, suspendido hace algún tiempo, hipertensión arterial, diabetes mellitus y tabaquismo, consulta por un cuadro de 7 días de evolución, caracterizado por desorientación, dolor abdominal, vómitos e ictericia. Al examen físico, presenta desorientación y lentitud del lenguaje, tiene frecuencia cardíaca: 89x', presión arterial 100/60 mmHg y asterixis. Al examen abdominal se evidencia ascitis grado 2 y dolor a la palpación abdominal. Sus pruebas hepáticas muestran: GOT 192 U/L, GPT 107 U/L, bilirrubina total 4 mg/dL y GGT 220 U/L. La protrombinemia es del 60%. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada para continuar con el estudio?

- ☐ a. Solicitar amonemia
- ☐ b. Solicitar TAC de cerebro
- ☐ c. Solicitar endoscopia digestiva alta
- ☐ d. Realizar paracentesis diagnóstica
- ☐ e. Solicitar ecografía abdominal

Evaluación de la Descompensación en Pacientes Cirróticos con Ascitis: En pacientes cirróticos con ascitis que experimentan cualquier tipo de descompensación, la evaluación diagnóstica debe comenzar con una paracentesis diagnóstica para descartar la peritonitis bacteriana espontánea.

La respuesta correcta es: Realizar paracentesis diagnóstica

Pregunta 85

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 31 años consulta por 2 meses de evolución de dolor abdominal y deposiciones diarreicas, inicialmente 3 veces al día, con aumento a 7 veces al día en las últimas 2 semanas. En el examen físico tiene FC: 88x', PA: 130/82 mmHg, T°: 36,0°C, abdomen blando, depresible, con meteorismo, sin masas ni visceromegalias, con ruidos hidroaéreos presentes y sin signos de irritación peritoneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Enfermedad de Crohn
- ☐ b. Enfermedad celíaca
- ☐ c. Colitis ulcerosa
- ☐ d. Colitis parasitaria
- ☐ e. Síndrome de intestino irritable

Diagnóstico Diferencial de la Diarrea Crónica: En un paciente con diarrea crónica (mayor a 4 semanas) que ha empeorado recientemente, la colitis ulcerosa es el diagnóstico más probable, considerando la evolución temporal de los síntomas. La enfermedad de Crohn es menos probable en ausencia de otros síntomas específicos. El síndrome del intestino irritable y la enfermedad celíaca habrían tenido una historia más prolongada en un paciente de esa edad.

La respuesta correcta es: Colitis ulcerosa

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una paciente de 58 años, menopáusica desde hace 10 años, sin terapia de reemplazo hormonal, consulta por metrorragia de 5 días de evolución, de intensidad variable, con una cuantía total de 100 ml. Al examen físico se observa pálida, con PA: 100/60 mmHg y FC: 90x'. Se realiza especuloscopia, que muestra salida continua de sangre desde el orificio cervical externo. ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Administrar anticonceptivos orales en alta dosis
- ☐ b. Realizar legrado uterino de urgencia
- ☐ c. Realizar histerectomía
- ☐ d. Administrar ácido tranexámico
- ☐ e. Realizar biopsia de endometrio

Estudio de la Metrorragia Posmenopáusica: La metrorragia posmenopáusica se puede evaluar inicialmente mediante ecografía transvaginal o con biopsia endometrial. Si la ecografía muestra un endometrio menor o igual a 4 mm, se presume atrofia endometrial y no se realiza biopsia. Sin embargo, si el sangrado persiste o el endometrio es mayor a 4 mm, se indica la biopsia.

La respuesta correcta es: Realizar biopsia de endometrio

Pregunta 87

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 50 años consulta por aumento de volumen en la región masetérica izquierda, de crecimiento lento y consistencia dura. Al examen físico se palpa un tumor de 2 cm de diámetro, ubicado sobre la rama mandibular izquierda, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ a. Lipoma
- ☐ b. Rabdomiosarcoma
- ☐ c. Adenopatía preauricular
- ☐ d. Tumor de parótida
- ☐ e. Quiste sebáceo

Tumor de Parótida: Un tumor ubicado en la zona descrita sugiere un tumor de parótida. Los tumores benignos son más frecuentes que los malignos. La parálisis facial y las adenopatías tumorales sugieren malignidad.

La respuesta correcta es: Tumor de parótida

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Una niña de 2 años de edad es traída por su madre a control de niño sano. Al examen físico se objetivan genitales con labios menores completamente adheridos entre sí en la línea media, lo que impide la visualización de la vagina y el meato urinario. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ a. Resección quirúrgica de las adherencias
- ☐ b. Realizar avulsión digital, bajo anestesia local con lidocaína
- ☐ c. Indicar aseo genital diario con vaselina líquida
- ☐ d. Aplicar pantenol tópico en la zona perineal por 15 días
- ☐ e. Aplicar betametasona tópica en la zona afectada por 10 días

Manejo de las Sinequias Vulvares: El tratamiento de las sinequias vulvares (adherencias labiales) es controvertido. La mayoría de los casos son asintomáticas y solo requieren observación. Sin embargo, el tratamiento tópico con estrógenos o corticosteroides se considera para las sinequias extensas (este caso), las que desvían el flujo urinario, causan dolor, o se asocian con flujo o infecciones recurrentes (vaginales o urinarias). Si en estos casos no hay mejoría después del tratamiento tópico, se puede considerar la cirugía. La cirugía también está indicada si las sinequias obstruyen completamente el flujo urinario.

La respuesta correcta es: Aplicar betametasona tópica en la zona afectada por 10 días

Pregunta 89

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 68 años con insomnio de conciliación, en tratamiento con risperidona 2 mg en la noche desde hace 4 días, evoluciona con angustia, inquietud psicomotora y aumento del insomnio. Refiere que se golpea las piernas por molestias y que ha tenido dificultades para dormir. Se automedicó con clonazepam, con mejoría parcial de los síntomas. ¿A qué tipo de efecto adverso corresponde el cuadro descrito?

- ☐ a. Acatisia
- ☐ b. Distonía aguda
- ☐ c. Disquinesia aguda
- ☐ d. Hipomanía
- ☐ e. Parkinsonismo por drogas

Acatisia: Es una acatisia clásica, causada por antipsicóticos y otros psicofármacos.

La respuesta correcta es: Acatisia

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia presenta un síncope de reposo sin pródromo, con recuperación completa. Al examen físico se encuentra orientado, en Glasgow 15, con frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

- ☐ a. Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas
- ☐ b. Ecocardiograma
- ☐ c. TAC de cerebro
- ☐ d. Resonancia magnética de cerebro
- ☐ e. Electrocardiograma

Evaluación del Síncope Cardiogénico: En un paciente con sospecha de síncope cardiogénico debido a una bradiarritmia, el electrocardiograma (ECG) es el examen inicial esencial. El ECG puede identificar bloqueos auriculoventriculares, enfermedad del nodo sinusal y alteraciones hidroelectrolíticas como la hiperpotasemia, que se asocian con este tipo de arritmias.

La respuesta correcta es: Electrocardiograma